HÍGADO: ENFERMEDADES BENIGNAS

DRA. LIZKA RICHARDS

LESIONES QUÍSTICAS: CLASIFICACIÓN

- Quísticas: quiste hepático simple, enfermedad poliquística del hígado, cistadenoma/cistadenocarcinoma, quiste hidatídico, absceso piógeno y absceso amebiano.
- Sólidas: hemangioma cavernoso, hiperplasia nodular focal, adenoma hepatocelular, adenomatosis, hiperplasia nodular regenerativa, angiomiolipoma.

QUISTE SIMPLE, POLIQUISTOSIS Y CISTADENOMA

- Quiste simple: incidencia 2.5-18%, casi siempre asintomático; tratamiento si es mayor a 6cm con síntomas (drenaje percutáneo o fenestración laparoscópica).
- Enfermedad poliquística (PLD): autósomica dominante, asociada a poliquistosis renal; manejo con drenaje o trasplante en casos avanzados; los análogos de somatostatina reducen el volumen hepático.
- Cistadenoma: 10-15% de riesgo de malignización; se trata con resección con márgenes libres; el cistadenocarcinoma requiere resección oncológica.

ABSCESOS HEPÁTICOS

- Hidatídico (Echinococcus): 90-95% de diagnóstico por ultrasonido y serología; PAIR + albendazol en casos no complicados, cirugía en complicados.
- Piógeno: gérmenes más frecuentes E. coli, S. aureus, Klebsiella; 53% asociado a diabetes; antibióticos de amplio espectro y drenaje percutáneo.
- Amebiano: antecedente de disentería 8-20 semanas antes; tratamiento con metronidazol o tinidazol; contenido característico en "pasta de anchoas".



HEMANGIOMA Y HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

- Hemangioma: el tumor sólido benigno más frecuente del hígado (70%); la RM tiene 95% de sensibilidad; los gigantes (>10cm) pueden causar el síndrome de Kasabach-Merritt.
- Manejo del hemangioma: observación en la mayoría de los casos; embolización, ablación o cirugía solo si es sintomático o complicado.
- Hiperplasia nodular focal (FNH): segundo tumor sólido benigno más frecuente; patrón en "rueda de carreta" en RM; sin potencial de malignización; manejo conservador.

ADENOMA HEPATOCELULAR

- Más frecuente en mujeres jóvenes (20-40 años); factor de riesgo principal: anticonceptivos orales en mujeres, esteroides anabólicos en hombres.
- Clasificación molecular: al menos 8 subtipos, incluyendo el sonic hedgehog, de alto riesgo hemorrágico.
- Manejo conservador: lesiones asintomáticas menores de 5cm, suspender la exposición hormonal, vigilancia con RM.
- Cirugía si: tamaño mayor a 5cm, todos los casos en hombres, mutación en beta-catenina, o lesiones sintomáticas.

ENFOQUE DIAGNÓSTICO Y TRASPLANTE

- Ante una lesión hepática incidental: evaluación clínica, laboratorios (AST/ALT, bilirrubinas, marcadores tumorales) e imagen multifásica con contraste (TC o RM).
- Trasplante por tumores benignos: solo 5 de cada 1000 trasplantes; se indica en tumores no resecables, sintomáticos o con riesgo de malignización.
- Principales indicaciones: adenoma/adenomatosis con riesgo hemorrágico, hemangioma gigante, poliquistosis hepática avanzada.